EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 85453
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2024-05-28 14:03:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA VERONICA CONTRERAS UNDA			**RUN**	: 10.040.541-5
F.Nac	: 11-09-1967	**Edad**	: 56 AÑOS, 8 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: CATALUÑA 063 VILLA ESPAÑA			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 94071699		
Fecha Ingreso	: 2024-05-27	**Fecha Egreso**	: 2024-05-28 14:03:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

INFECCIÓN URINARIA POR E. coli. BLEE
HTA
DM NIR
DLP
HIGADO GRASO
TRASTORNO DEPRESIVO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente Femenina De 56 Años, Con Antecedentes Mórbidos De Hta, Dmnir, Depresion En Tto Regular Con Clonazepam, Quetiapina, Aspirina, Litio, Metformina,. Sin Alergia Conocidas .
Consulta Por Segunda Vez Al Servicio De Urgencia Por Presentar Dolior En Hipogastrio , Distensión Abdominal, Disuria, Orinas Coluricas De Mal Olor, Recibio Ttoo Con Cefadroxilo Sin Mejoria, Se Rescata Urocultivo Positivo Para E Coli Blee (+), Se Realiza Examenes De Laboratorio Destaca Proteina C Reactiva : 591,1 Hemoglobina : 12,7 G/Dl Hematocrito : 38,0 O/O Recuento De Leucocitos : 16,10 * Mil/Ul Recuento Hematies : 4,20 Mill/Ul Plaquetas : 200 Segmentados : 72 O/O Linfocitos : 15 Creatinina : 0,70 Mg/Dl
Clearence Calculado(Mdrd) : 86,56,.
Tac De Abdomen Y Pelvis: Hepatomegalia Con Esteatosis Difusa, Ateromatosis Calcica, Diverticulosis Colonica. En Vista Del Compromiso Hemodinámico Y Parámetros Inflamatorio Elevados Se Indica Ingreso Al Servicio Para Tto Atb .
Al 3er dia con Ertapenem pcte en BCG, asintomatica, afebril, HDN estable, con parametros infalamatorios a la baja, orinas claras y sin mal olor.
POR TODO LO ANTERIOR SE DECIDE COMPLETAR TTO ATB EN HODOM.

PLAN DE MANEJO:

COMPLETAR TTO ATB EV EN HODOM

INDICACIONES AL ALTA

1. TRASLADO A HODOM
2. REPOSO RELATIVO ASISTIDO

3. RÉGIMEN HIPOSODICO PARA DIABETICOS
4. ERTAPENEM 1 GR AL DÍA EV, COMPLETAR 7 DIAS (HOY 3/7)
5. PARACETAMOL 500 MG, 2 COMP C/8 HRS VO SOS
6. OMEPRAZOL 20 MG AL DIA VO POR 10 DIAS
7. RESTO TRATAMIENTOS CRONICOS HABITUALES MANTENER
8. CONTROL POST ALTA DE HODOM EN APS
9. CONTROL SOS VIA URGENCIA
10. CONTINUAR CONTROLES CRONICOS APS

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO